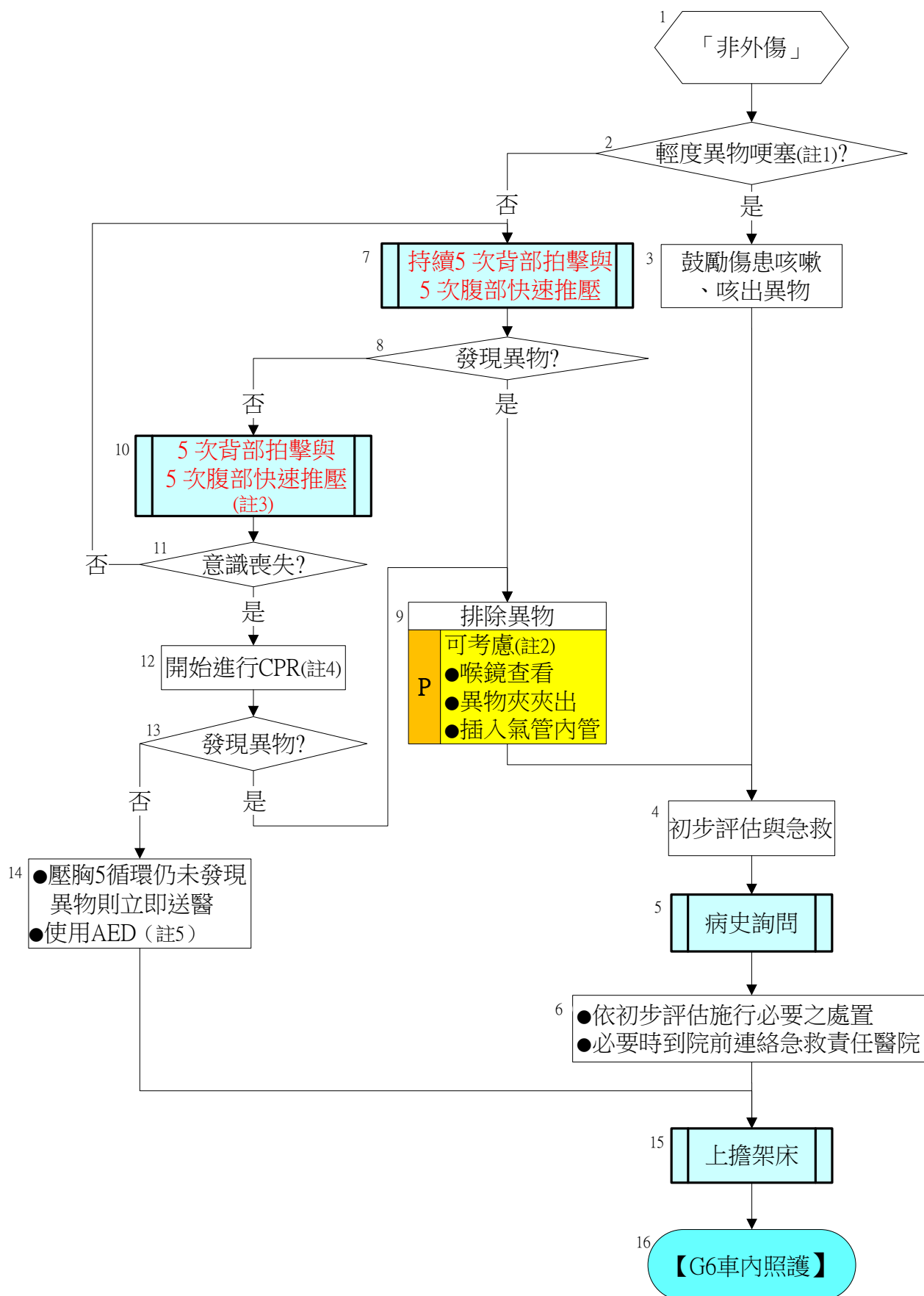


A3 異物哽塞

程 序



要 旨

- 一、1歲以上清醒病患主訴「異物哽塞、被食物或異物噎著了」，即建議使用本程序。
- 二、在明顯因異物哽塞造成之OHCA，於異物排除前EMT不可進行放置 SGA。

註 解

註1＞

病人正用力呼吸及咳嗽。

註2＞ **P**

- 一、可考慮使用喉鏡查看是否有異物。
- 二、若發現異物可使用異物夾夾出，如異物無法夾出且可目視聲帶時，可考慮*置入氣管內管（參考「A1成人氣管內管插管」）。

註3＞

可每5次背部拍擊與5次腹部快速推壓(持續觀察異物)檢查1次有無異物（為一回合）。操作4回合後仍無法將異物排除，且病人意識未喪失時：

- 一、立即將病人搬運至救護車上，持續執行異物排除及其他初步評估施行必要之處置，必要時到院前連絡急救責任醫院。
- 二、**P**可考慮使用喉鏡查看是否有異物；若發現異物可使用異物夾夾出，如異物無法夾出且可目視聲帶時，可考慮*置入氣管內管。

註4＞

當異物無法排除且病人意識喪失時，此時進行CPR按壓，惟急救過程不放置SGA及延後AED使用。

註5＞

若操作第2循環按壓（30次）仍未排除哽塞時，副手應考慮使用AED，待第5循環按壓結束後仍未排除時，立即使用AED，操作過程中查看口中有無異物，並聽從AED指示操作後，儘速離開現場送醫。